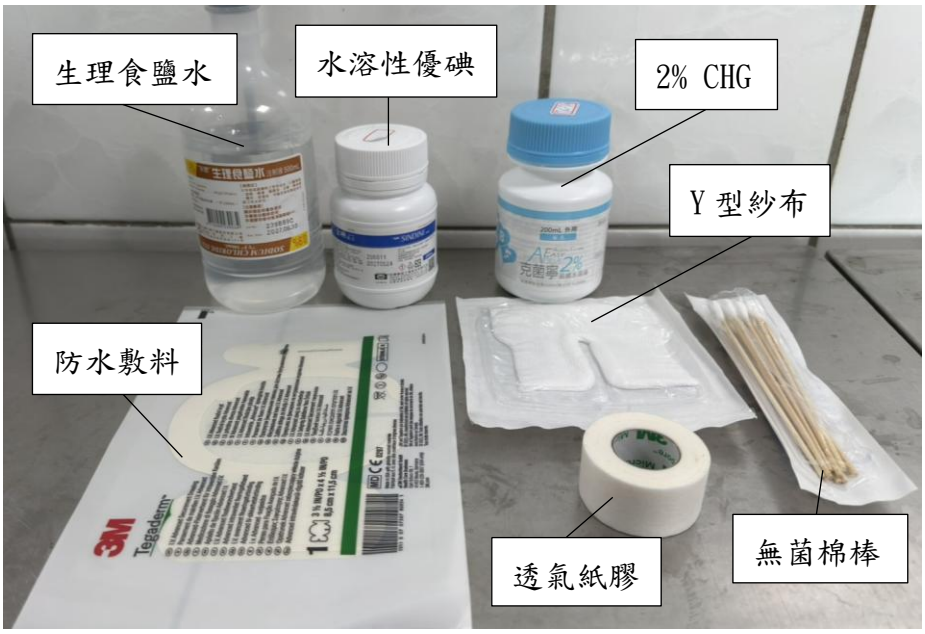
經皮穿肝膽囊引流術(PTGBD)管路照護護理指導

一、 何謂 PTGBD 引流管?

PTGBD 引流管為經皮經肝膽囊引流管，是經由皮膚穿刺將引流管放入膽囊內，將膽汁引流至體外，主要用於急性膽囊炎、膽道阻塞或暫時無法手術的病人，以減少膽囊壓力、控制感染並緩解不適症狀。當病情改善後，醫師會依恢復情形評估是否拔除引流管。

二、 PTGBD 置入口傷口護理

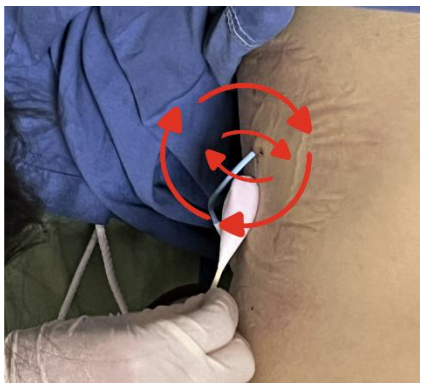
(一) 準備用物：無菌敷料（可至藥局購買 4x4 無菌 Y 型紗布）或 3M 導管固定防水透氣敷料、無菌棉棒、生理食鹽水、水溶性優碘（非酒精性）或 2% CHG（非酒精性)、透氣紙膠(如圖一)。



(圖一)

(二) 換藥步驟

1. 以洗手乳或酒精乾洗手液洗手後，移除傷口敷料。
2. 檢視傷口周圍皮膚是否有感染現象，如紅腫熱痛，或是出現像膿狀、臭味之滲出物。
3. 將水溶性優碘或 2% CHG 沾滿優碘棉棒上，由內向外環狀消毒傷口周圍 5 公分皮膚(如圖二)，並由近端向遠端擦拭引流管(如圖三)。



（圖二）

（圖三）

4. 若使用水溶性優碘須等待 2 分鐘，再將無菌生理食鹽水倒至棉棒上並依相同方式擦拭，且棉棒不可重複使用。
5. 取出 4x4 Y 型紗布或 3M 導管固定防水透氣敷料覆蓋引流管傷口，手指抓住 Y 紗兩邊角，勿觸摸紗布中間部分，以免造成感染，再用紙膠將紗布四周黏貼妥當即可(如圖四、五)。

（圖四）

（圖五）

6. 清潔用物並洗手。

（三） 換藥頻率

觀察引流管傷口外觀乾淨，以紗布覆蓋需每三天換藥一次；以防水透氣敷料覆蓋則每七天換藥一次，若觀察傷口有分泌物或發紅，則需每天更換；弄髒潮濕時應立即更換紗布。

三、 引流管照護注意事項

（一） 避免引流管牽扯，可將引流管夾在同側腰際衣物上，並維持引流管通暢，注意管路不可扭折。

（二） 引流袋自然下垂，無論採任何姿勢，引流袋應低於傷口，以防引流液逆流。

（三） 引流袋約八分滿時，需將引流液倒出，執行前請先洗手，將引流袋下方排出口打開，緩慢將引流液倒入乾淨容器中，注意排出口勿碰觸容器，完成後將排出口關緊，並記錄引流液完整 24 小時的量、顏

色、氣味及性質，一般顏色呈黃褐色、金黃色或黃綠色，若是放置後三日內，引流液呈現紅色是正常現象。

四、 當您出現以下情況時，請儘速就醫：(一）引流管周圍皮膚持續發紅、腫脹、出血、疼痛加劇、傷口出血或有滲液。(二）引流管滑出或脫落，請以無菌紗布覆蓋，並儘速就醫。(三）引流液之性質與顏色明顯改變，或引流量突然減少。(四)有發燒情形且超過 4 小時，如耳溫、口溫大於 37.5℃或腋溫大於 37℃。

五、 參考資料

Rerknimitr, R., & Pham, K. C. (2020). Practical Approaches for High-Risk Surgical Patients with Acute Cholecystitis: The Percutaneous Approach versus Endoscopic Alternatives. Clinical endoscopy, 53(6), 678–685. https://doi.org/10.5946/ce.2019.186

六、 護理指導評值

※是非題

1. (　) 無論坐著、躺著或站著，PTGBD 引流袋都應自然下垂，並保持低於傷口位置，避免引流液逆流。
2. (　) 如果傷口敷料出現潮濕、弄髒、滲液或傷口發紅，不必立即換藥。
3. (　) 為了避免引流管被拉扯，下床活動時需將引流管固定在同側腰際衣物上，並注意管路保持通暢、不扭折。
4. (　) 若出現引流管滑出或脫落、引流量突然減少，或發燒超過 4 小時，可以先在家休息觀察，不必立即就醫。
5. (　) 倒引流液前應先洗手，再將引流液緩慢倒入乾淨容器中，且排出口不要碰觸容器。
6. (　) 當 PTGBD 引流管不小心滑出或脫落時，自行將管路推回原位再觀察是否有不適即可。

（答對 5-6 題⇨完全了解；答對 3-4 題⇨部分了解；答對 1-2 題⇨完全不瞭解）